

NS			
ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA			
IDADE: 81 anos.	PESO: 62	ALTURA: 1,69	PROFISSÃO: Administrador
SINTOMAS: <u>nêvros;</u>			
QUEIXAS: <u>labirintite - AVC há 1 ano;</u>			
MEDICAMENTOS: <u>IAM - 1 stent - MAS inclapril, Amlodipina / transcorina (mãe),</u> <u>colesterol (mucilágnea), Denonon, glaucoma</u>			
MÉDICO: <u>Dr. Dr. Renato Félix Bauab (neuro SP) / Dra. Catharina</u> <u>(Otorrino)</u>			
EXERCÍCIO FÍSICO: <u>Academia 2x; Tênis 2x;</u>			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ:		ALMOÇO:	LANCHE: JANTAR:
HORA QUE DORME: <u>00:30</u>		HORA QUE ACORDA: <u>8:30</u>	
COCHILO () SIM () NÃO		DORME ACOMPANHADO () SIM () NÃO () EVENTUAL	
BEBIDA ALCOÓLICA (X) SIM () X NA SEMANA () NÃO <u>vinho 1x dia e fds.</u>			
FUMO (X) SIM () MAÇO/DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: <u>há 40 anos.</u>			
TIPO DE RESPIRAÇÃO:		BANHEIRO:	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP:	MALLAMPATI:	IAH: <u>60,9</u> e/h	SPO2: <u>81%</u>
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:			
CIRURGIAS: (X) NASAL (X) AMIGDALECTOMIA <u>(septo há 6 anos / Amígdala qdo criança)</u>			
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:			
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA			
() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS			
PSG com CPAP: <u>títulação 6 cmH₂O</u>			
11/09/23 - <u>doação Elite P-6 cmH₂O. Másc. Suíte (M)</u>			
18/09/23 P= 6 cmH ₂ O			
IAH= 3,5 e/h <u>teste máscara.</u>			
m de uso= 6h10'			
fuga= 29 l/min			
25/09/23 P= 6 cmH ₂ O <u>Bem ajustado másc.</u>			
IAH= 1,5 e/h			
m de uso= 6 horas			
fuga= 29 l/min			
02/10/23 P= 6 cmH ₂ O <u>Relato melhora do que</u>			
23 IAH= 1,3 e/h <u>dro, melhora da pressão</u>			
M. de uso: 5h46' <u>do peito — — — — —</u>			
16/10/23 P= 6 cmH ₂ O <u>Bem do posto / Adaptado</u>			
IAH= 0,8 e/h <u>silenc</u>			
m de uso= 7h10'			
fuga 29			
06/11/23 P= 6 cmH ₂ O <u>Bem Adaptado Ance</u>			
IAH= 1,4 e/h			

IAH = 0,7
m de uso: 6h40min
fuga: 22l/min

Bem adaptado
foz espote
oriento higiene máx * troca filtro

06/02/24 P= 6cm H₂O
IAH = 0,6 e/h
m. de uso: 6h34'
Fuga: 23,4 l/min.

Bem disposto, mas
a mar. pouco higienizada
fua.

05/04/24 P= 6cm H₂O
IAH = 0,7 e/h
m de uso: 6h32m
fuga: 27,2 l/min

Bem adaptado
* Troca filtro
Natasha

07/06/24 P= 6cm H₂O
IAH = 3,4 e/h
m de uso: 4h57m
fuga: 26,9 l/min

Oriento colocação
da máscara
* troca filtro

16/08/2024 P= 6cm H₂O
IAH = 2,9 e/h
m de uso: 7h20min
fuga = 55 l/min

Natasha
Bem adaptado
Silvia

22/10/2024 P= 6cm H₂O
IAH = 4,9 e/h
m de uso: 6h5'
fuga: 43,4 l/min

Bem adaptado
Natasha

15/01/2025 P= 6cm H₂O.
IAH = 1,0
m uso = 6h40min
fuga: 44l/min

Bem adaptado

Silvia
* troca prong *
e filtro
oriento higieniza

15/04/2025 P= 6cm H₂O
IAH = 2,8 e/h
m uso = 7horas
fuga: 42l/min

zome tarde

Bem Adaptado
* troca filtro *
oriento higiene

Silvia
→

04/08/25 P=6cm/1h0

IAH=4,8el/h

muuo=7h25min

fuga=53l/min

mls escape - aparelho derrogou
ajuste mananca

* how fêto *

Silva

Nome: ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA
Data de Nascimento: 11-10-1942
IMC: 21,71
Sexo: Masculino
Data do exame: 04-04-2023

Peso: 62 kg
Altura: 1,69 m
Médico: DR. JOSE RENATO FELIX
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 04-04-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 487,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 126,0 e 121,0 minutos. O tempo total de sono foi de 290,5 min, eficiência de 59,6% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,2%; estágio N2: 68,3%; estágio N3: 6,9%; sono REM: 23,6%. O índice de despertares foi de 30,5/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 60,9/hora, sendo 50 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 104 hipopnéias. A SpO2 média foi de 90% e a mínima de 81%, permanecendo 16,0% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 51 - 67 bpm e NREM de 47 - 69 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (10), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 60,9/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=81%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (2,7/hora);
8. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57.157

Dr. José Renato Felix Bauab

Neurologia – Distúrbios do Sono
CRM: 83.614

Antonio Augusto de Souza

Solicito uso do CPAP para Apnéia do Sono grave, ajustado com pressão de 6 cm de H₂O, com rampa de 2 minutos e uso de máscara nasal com umidificador.

Grato,

[Handwritten signature]

Rua Barata Ribeiro, 490 – Conj. 106

Bela Vista – CEP.: 01308-000 – São Paulo – SP

Fone/Fax: (11) 3129-9971 / 3256-8786 – Cel. 99602-7878